

INNA TRI

RUNNING ESSENTIAL STUDIO

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Возвращение после перерыва

Четыре сценария, схемы первых недель и честные критерии: когда можно, а когда рано.

Инна Рыжих

Тренер по бегу и триатлону

20 лет в спорте · 10 лет практики



Что внутри

Прежде чем начнём	3
Почему форма уходит быстрее, чем строилась	5
Главный принцип возврата	11
Определите свой сценарий	14
Отпуск и плановый отдых	16
Болезнь	21
Травма	26
Выгорание	32
По чему мерить прогресс вместо темпа	35
Красные флаги	39
Чек-лист первой недели	41
Что дальше	43
На чём основан гайд	45

Это образовательный материал, а не медицинская рекомендация. Если перерыв связан с травмой, болезнью сердца или любым состоянием, которое лечит врач - решение о возврате к нагрузкам принимает врач, а не гайд из интернета.

Прежде чем начнём

Я двадцать лет в триатлоне и десять лет тренирую. За это время у меня было всё: отпуска, вирусы с температурой, травмы и период, когда просто не хотелось надевать кроссовки.

3:35

мой темп на десятке в лучшие спортивные годы

6:00

мой комфортный темп сегодня

0

сколько меня это расстраивает

Этот гайд - про то, что я делаю сама и что пишу своим спортсменам, когда перерыв уже случился. Без «просто начните постепенно». С цифрами, схемами и понятными критериями.

Как пользоваться

Первые две части - общие, их стоит прочитать всем: там физиология и принцип, на котором держится всё остальное. Дальше начинаются сценарии. Найдите свой и работайте по нему.

Части 8-10 - инструменты. Ими пользуются в процессе: чем мерить прогресс, когда останавливаться и что проверить в первую неделю.

Дисклеймер

Это образовательный материал, а не медицинская рекомендация. Если перерыв связан с травмой, болезнью сердца или любым состоянием, которое лечит врач - решение о возврате к нагрузкам принимает врач, а не гайд из интернета.

Почему форма уходит быстрее, чем строилась

Самый частый вопрос после перерыва: я же тренировался месяцами, почему всё ушло за две недели?

Ответ простой. Ваш привычный темп никогда не был для организма нормой. Это дорогой режим работы, и платить за него нужно каждую неделю.

Что уходит первым

Не «выносливость». Первым падает объём крови.

При полном перерыве в 2-4 недели объём плазмы падает примерно на 12%, общий объём крови - примерно на 9%. Ударный объём сердца снижается уже на 4% за две недели.

Цифры ниже - результаты отдельных исследований у тренированных спортсменов, а не обязательные изменения у каждого бегуна. Полный отказ от нагрузки и сокращение тренировок дают разную картину.

Отсюда берётся «+10 к пульсу»

Меньше крови выбрасывается за один удар - значит, чтобы доставить мышцам тот же кислород, сердцу нужно больше ударов в минуту. Вот одна из причин более высокого пульса на привычном темпе. Сон, жара, стресс и болезнь тоже влияют.

Что уходит следом

- Митохондриальный аппарат: активность окислительных ферментов падает примерно на 29% уже за 10 дней и примерно на 40% за восемь недель
- Плотность капилляров - примерно -6% за 15 дней
- Запасы мышечного гликогена - примерно -18% за месяц сниженной нагрузки

Что держится дольше всего

Беговая экономичность. При двухнедельном перерыве изменений в экономичности бега исследования не фиксируют. Техника и нейромышечный рисунок - самое стойкое из всего, что вы построили.

Вы не разучились бегать. Вы временно везёте меньше кислорода. Это разные вещи, и лечатся они по-разному.

Что происходит по неделям

Карта потерь

Это обобщённая карта, собранная из разных исследований. Проценты не описывают одного человека и не складываются. По ним нельзя вычислить дату возвращения формы.

5-7 дней

VO2max: $\approx 0\%$

Что происходит: падает объём плазмы, чуть выше пульс

2 недели

VO2max: -5%

Что происходит: -12% плазмы, -4% ударного объёма, -29% ферментов

3-4 недели

VO2max: -4...-6%

Что происходит: подключается митохондриальный спад

5-6 недель

VO2max: -10%

Что происходит: заметно падает порог, темп «не идёт»

8 недель

VO2max: -13%

Что происходит: -40% активности окислительных ферментов

12+ недель

VO2max: –13...–15%

Что происходит: дальше падает медленнее, но база перестроена

Срок возврата индивидуален: он зависит от причины перерыва, исходной подготовки и переносимости нагрузки.

Источник цифр: систематический обзор по детренированности у спортсменов на выносливость, *Frontiers in Physiology*, 2024; Mujika & Padilla, *Sports Medicine*, 2000.

Почему организм так делает

Вашим мышцам не интересны километры сами по себе. Организм решает другую задачу: удержать стабильный гомеостаз, сберечь гормональную систему, дожить до завтра в рабочем состоянии.

Аэробная машина, которую вы строили, - дорогая в обслуживании. Как только регулярная нагрузка исчезает, тело первым делом срезает самое затратное.

Это не поломка. Это разумная экономия.

Хорошая новость

Вернуть форму почти всегда быстрее, чем построить её с нуля. Объём плазмы восстанавливается за считанные дни регулярных тренировок - это самый быстрый из всех механизмов. Нейромышечный рисунок и техника никуда не делись.

Месяцы подготовки не обнуляются за один отпуск.

Главный принцип возврата

Запомните порядок. Он работает почти всегда.

Сначала: частота

вернуть привычное количество тренировок в неделю

Потом: длительность

наращивать объём каждой тренировки

И только потом: интенсивность

пороги, интервалы, темповая работа

Большинство делает ровно наоборот. Выходит после двух недель и в первый же день пытается бежать прежний темп - потому что «надо проверить, что осталось».

Проверять прежний темп в первый же день незачем. Один такой тест не покажет, сколько формы осталось. Проверка ничего не добавит, а риск добавит.

Три правила поверх принципа

01 Правило 50%. После отдыха 50-60% прежнего объёма можно рассматривать как осторожную отправную точку, а не обязательную норму. После болезни или травмы объём выбирают по состоянию и ограничениям, а не по проценту.

02 Правило постепенности. Не прибавляем объём и интенсивность одновременно. Скучно? Да. Это и есть режим «дятла». 10% - не универсальный предел и не гарантия от травм; шаг прибавки зависит от исходной нагрузки и восстановления.

03 Правило соотношения. Чем дольше и тяжелее был перерыв, тем больше времени стоит оставить на возвращение. Но «неделя возврата на неделю перерыва» - не формула. После долгой паузы речь идёт уже о новом базовом цикле.

Определите свой сценарий

Дальше универсального ответа нет. И это не отговорка тренера.

Отпуск, вирус с температурой, травма и выгорание - четыре принципиально разных сценария. У них разная физиология, разные риски и разные критерии допуска.

О1 / Отпуск и плановый отдых

Главный риск - слишком быстрый разгон. Возврат ограничен объёмом.

О2 / Болезнь

Главный риск - сердце и иммунитет. Возврат ограничен симптомами.

О3 / Травма

Главный риск - повторная травма. Возврат ограничен критериями допуска, а не сроком.

О4 / Выгорание

Главный риск - уйти из спорта совсем.

Возврат зависит от общего состояния, а не только от желания тренироваться.

Найдите свой блок ниже.

Отпуск и плановый отдых

Протокол 01

Самый простой сценарий. Тело здорово, ограничение одно - не разгоняться быстрее, чем восстанавливается кислородный транспорт.

Если перерыв до 10 дней

Возвращайтесь почти сразу, если самочувствие обычное. Первая тренировка - обычная лёгкая, минус 20-30% длительности как ориентир. Со второй недели структура может стать прежней, если нагрузка переносится спокойно.

Единственное: первые 3-4 тренировки не смотрите на темп вообще. Пульс может быть выше привычного, но фиксированной «нормальной» прибавки для всех нет.

Если перерыв 2-4 недели

Пример для того, кто бегал 5 раз в неделю, 50 км.

Учебный пример после отдыха для здорового бегуна. Недели - не обязательные дедлайны. При плохом восстановлении этап повторяют или упрощают; ускорения и пороговую работу не добавляют автоматически.

Неделя 1 / Частота

Объём: 25-30 км

Что добавляем: ничего нового, только вернуть 5 тренировок в неделю

Интенсивность: 4-6 ускорений по 20 сек, только при хорошей переносимости

Неделя 2 / Длительность

Объём: 35-40 км

Что добавляем: длительная 60-70% от обычной

Интенсивность: только ускорения

Неделя 3 / Интенсивность

Объём: 42-46 км

Что добавляем: длительная 80% от обычной

Интенсивность: 2×8 мин в пороговом или 6×3 мин, если есть готовность

Неделя 4 / Норма

Объём: полный, если предыдущие этапы переносились спокойно

Что добавляем: обычная структура недели

Интенсивность: полноценная, при готовности

Все лёгкие тренировки первых двух недель - в 1-2 зоне, разговорный темп. Никаких «проверить, что осталось».

Если перерыв больше 6-8 недель

Это уже не «возвращение», а новый базовый цикл.

Закладывайте время на аэробную работу, прежде чем добавлять пороги и интервалы. 4-6 недель - возможный ориентир, а не обязательный срок. Попытка перепрыгнуть этот этап может повысить риск проблем на возврате.

Как выглядит базовый цикл

Недели 1-2

Что делаем: вернуть посильную частоту, около 50% объёма как ориентир, всё в 1-2 зоне

Интенсивность: нет

Недели 3-4

Что делаем: постепенно увеличивать объём по переносимости, появляется длительная

Интенсивность: только ускорения 15-20 сек, если переносимость позволяет

Недели 5-6

Что делаем: объём приближается к целевому, длительная растёт

Интенсивность: первые пороговые блоки при готовности

Недели 7+

Что делаем: обычная структура недели при готовности

Интенсивность: полноценная

Частая ошибка

После долгого перерыва тело первые две недели чувствует себя подозрительно хорошо: вы отдохнувший, свежий, ничего не болит. Это ощущение обманывает.

Сердце, мышцы, сухожилия и кости адаптируются не одинаково быстро. Хорошее дыхание и свежесть ещё не означают, что опорно-двигательный аппарат готов к прежнему объёму.

Болезнь

Протокол 02

Здесь спешка стоит дороже всего. Не из-за формы - из-за сердца.

Тренироваться или нет: проверка «выше шеи»

Заложенный нос, лёгкая боль в горле и чихание без температуры сами по себе не дают разрешения на бег. Оцените общее состояние и оставшиеся симптомы. При температуре, ломоте, сильной слабости, симптомах со стороны груди тренировок нет. Совсем. Никаких «пробегу спокойно, продышусь».

Правило возврата после температуры

Не тренируйтесь, пока держится температура. Дальше решение зависит от тяжести болезни и оставшихся симптомов, а не от формулы «день отдыха за день температуры». После тяжёлого течения, при затяжных симптомах или новых ощущениях со стороны сердца и дыхания сначала обратитесь к врачу.

Первый этап

Что делаем: возвращаем обычную бытовую активность, когда состояние позволяет

Что контролируем: самочувствие и симптомы

Следующий этап

Что делаем: короткая лёгкая нагрузка, если возвращение допустимо

Что контролируем: реакцию во время, после и на следующее утро

Дальше

Что делаем: постепенно возвращаем лёгкие тренировки

Что контролируем: восстановление между тренировками

Интенсивность

Что делаем: добавляем только после устойчивой переносимости лёгкой работы и с учётом медицинских рекомендаций

Что контролируем: самочувствие и реакцию на нагрузку

Этапы выше не привязаны к дням 1-2, 3-4, 5-7, 8-14 и 15. Если во время возвращения стало хуже, остановитесь; не переходите дальше по календарю.

Красные флаги после болезни

Это к врачу, а не к тренеру

Остановитесь и обратитесь к врачу, если после болезни появляется что-то из этого списка.

- Боль, давление или жжение в груди при нагрузке
- Одышка, несоразмерная нагрузке
- Сердцебиение или перебои в покое
- Обмороки, предобморочные состояния
- Отёки ног
- Стойко необычный для вас пульс в покое, особенно вместе с другими симптомами; не нужно ждать неделю при ухудшении.
- Необъяснимое падение переносимости нагрузки, которое не улучшается

Именно вокруг этих симптомов строится оценка возврата к спорту после вирусных инфекций. Среди возможных причин - миокардит, но по списку симптомов диагноз не поставить. До оценки врача не тренируйтесь. Это не единственная ситуация, в которой нагрузку нужно отложить.

При внезапной непрекращающейся боли или давлении в груди, особенно с одышкой, холодным потом или предобмороком, нужна экстренная помощь. Прекратите нагрузку и вызовите местную экстренную службу. Не ждите записи к тренеру или планового приёма.

Почему это важнее формы

Потерянная форма может вернуться, но не по гарантированному расписанию. Бежать «на характере» через возможное воспаление сердечной мышцы опасно. Это тот редкий случай, когда осторожность стоит дешевле любой альтернативы.

Травма

Протокол 03

Здесь вопрос вообще не в объёме.
Вопрос в критериях допуска.

Главная ошибка - считать недели.
«Прошло четыре недели, значит можно бежать». Нет. Можно, когда выполнены критерии возвращения, подобранные под вашу травму со специалистом.

Критерии перед первым бегом

Это ориентиры для обсуждения с врачом или физиотерапевтом, а не самостоятельный допуск. Для разных травм критерии и допустимая боль различаются.

- Ходьба 30 минут без боли
- Подъём и спуск по лестнице без боли
- Прыжковые тесты - только если специалист считает их подходящими для вашего повреждения.
- Боль в покое 0 из 10
- Нет отёка сустава, нет утренней скованности дольше 30 минут

Правило 24 часов

После каждой сессии смотрим на следующее утро.

Наутро не хуже

Что делаем: продолжаем только в рамках согласованных критериев

Боль усилилась или сохраняется

Что делаем: не прогрессируем; корректируем нагрузку со специалистом

Боль меняет вашу технику бега

Что делаем: остановка, к специалисту

Порог 2/10 не универсален. Особенно при костной стрессовой травме нельзя считать любую слабую боль допустимой.

Бег / ходьба

Протокол первого возврата

Пример схемы после допуска к бегу, а не общий протокол для всех травм. Отрезки и частоту согласуют со специалистом. При ухудшении нельзя продолжать только потому, что подошла следующая сессия.

Через день, не подряд. Прогрессируем по времени бега, а не по темпу. Темп на этом этапе не существует.

Сессии 1-2

1 мин бег / 2 мин шаг × 8

Всего бега: 8 мин

Сессии 3-4

2 мин бег / 2 мин шаг × 7

Всего бега: 14 мин

Сессии 5-6

3 мин бег / 1 мин шаг × 7

Всего бега: 21 мин

Сессии 7-8

5 мин бег / 1 мин шаг × 5

Всего бега: 25 мин

Сессии 9-10

10 мин бег / 1 мин шаг × 3

Всего бега: 30 мин

Дальше

непрерывный лёгкий бег

Всего бега: 30 мин

Ступень не проходит автоматически по номеру сессии. Оценивайте реакцию во время, после и на следующий день по согласованным критериям. Не «вроде терпимо», а честно: наутро не хуже.

Пока бег нежелателен

Чем держать базу

Это то, что чаще всего упускают, и зря. Часть аэробной формы можно поддерживать без ударной нагрузки, если выбранная активность разрешена при вашей травме.

Велосипед / станок

легче всего набирать объём, нет ударной нагрузки

Плавание

плюс работа с дыханием, разгружает опорно-двигательный аппарат

Эллипс

ближе всего к беговому рисунку, если нет вела

Гребной тренажёр

хорош для триатлетов, добавляет спину и корпус

Перенос на бег зависит от интенсивности, опыта и состояния; эти виды нагрузки не взаимозаменяемы один к одному.

Главное про объём

Считайте объём по времени, а не по километрам. Час на велостанке - это час аэробной работы, а не «всего 30 км». Как только вы начинаете сравнивать километры, вы автоматически обесцениваете всё, что делаете, и тянетесь обратно к бегу раньше времени.

И ещё

Период без бега может быть временем для согласованной силовой работы. Какие упражнения подходят, зависит от травмы. Если она уже случилась, важно не просто вернуться в прежний объём, а разобраться, что стоит изменить в подготовке.

Выгорание

Протокол 04

Самый недооценённый сценарий. Потому что кажется, что проблема только в дисциплине. Но стойкая усталость требует внимания к здоровью, а не вывода «тело здорово».

Лень

Не хочется начинать. Но начал - и втянулся.

Выгорание

Начал - и всю тренировку пусто.

Это образное сравнение, не диагностика. Если симптомы сохраняются или затрагивают жизнь вне спорта, обратитесь к врачу; при необходимости - к специалисту по психическому здоровью.

Другие признаки

- Утренний пульс стабильно выше нормы без болезни
- Рваный сон, ранние пробуждения

- Раздражительность, которой раньше не было
- Старты не радуют, а напрягают
- Падает результат при том же объёме

Главная ошибка

Лечить выгорание дисциплиной. Добавить объёма, «взять себя в руки», поставить цель посерьёзнее. Это доливать бензин в двигатель, у которого заклинило поршень.

Протокол

Длительность фаз ниже - пример организации возвращения, не схема лечения. Она меняется по состоянию. При болезни или выраженной стойкой усталости сначала нужна оценка причин.

01 Фаза 1, 2-3 недели. Бег только по желанию. Без часов. Без структуры. Пропустили три дня - ничего не случилось. Разрешите себе другой спорт: горы, плавание, велопрогулки, что угодно, где нет плана.

02 Фаза 2, 2-3 недели. Возвращаем частоту, но не цели. 3-4 короткие лёгкие пробежки в неделю. Часы можно надеть, но темп не смотрим.

03 Фаза 3. Возвращаем цель - и только теперь смотрим на календарь стартов. Соревнования не должны подгонять возвращение; первые недели оставьте без давления результата.

Отдельно: смените среду. Новые маршруты, группа, партнёр по тренировкам. Смена контекста может помочь вернуть интерес, но не заменяет помощь при стойком ухудшении состояния.

По чему мерить прогресс вместо темпа

На время возврата прошлые цифры на часах перестают быть мерилom. Но мерить что-то всё равно надо - иначе непонятно, работает ли план.

01 Утренний пульс. Мерить лёжа, сразу после пробуждения, до телефона.

Устойчиво выше вашей нормы - повод оценить сон, самочувствие и нагрузку, а не ставить диагноз по одному числу.

02 Пульс на фиксированном лёгком темпе. Один из маркеров возврата формы. Выберите один и тот же круг и сравнивайте тренировки в похожих условиях. Со временем нагрузка может ощущаться легче, а пульс снижаться. По одной цифре нельзя судить, что именно восстановилось.

03 Разговорный тест. На лёгкой тренировке вы можете говорить целыми предложениями. Не можете - темп слишком высокий, независимо от того, что показывают часы.

04 Восстановление между тренировками. Утром после лёгкой пробежки вы должны чувствовать себя нормально. Если после лёгкой тренировки нужен день отхода - объём завышен.

05 Дрейф пульса на длительной. Разделите длительную пополам. Темп держите один и тот же, а средний пульс сравните: первая половина против второй.

Небольшой дрейф в сопоставимых условиях может быть полезным наблюдением. Большой дрейф требует оценки жары, жидкости, усталости и выбранной нагрузки. Ни 5%, ни 10% сами по себе не дают допуска к интенсивности.

Считается вручную по любым часам, никаких специальных сервисов не нужно.

Нормальная динамика по неделям

Чего ждать

Речь про пульс на вашем привычном лёгком темпе, в сравнении с тем, каким он был до перерыва.

Неделя 1

Пульс может быть выше привычного; оцениваем ощущения и условия.

Недели 2-3

Ищем тенденцию, а не обязательное снижение на определённое число ударов.

Недели 4-6

Смотрим на переносимость нагрузки. Сам календарь не даёт допуска к качественной работе.

Если динамики нет

Если через 3-4 недели возврата пульс на лёгком темпе не снижается, посмотрите на сон, питание, стресс, условия и сам план. При стойком ухудшении самочувствия обратитесь к врачу: причины, включая дефициты, нужно выяснять, а не угадывать. Тренировочный план не лечит дефициты.

Что записывать

Раз в неделю - три числа: утренний пульс, средний пульс на контрольном круге, и ощущение по шкале от 1 до 10. Три числа в неделю дают больше, чем любой трекер: через месяц вы увидите тренд, а не шум.

Красные флаги

Общий стоп-лист, независимо от сценария.

Экстренная помощь

При внезапной непрекращающейся боли или давлении в груди, особенно с одышкой, холодным потом или предобморком, нужна экстренная помощь. Прекратите нагрузку и вызовите местную экстренную службу. Не ждите записи к тренеру или планового приёма.

К врачу

- Боль, давление или жжение в груди при нагрузке
- Одышка, несоразмерная нагрузке, головокружение, предобморок
- Перебои в сердце в покое
- Стойко необычный пульс в покое, особенно вместе с другими симптомами

Остановка и медицинская оценка

- Боль, которая заставляет менять технику бега
- Боль, которая будит ночью
- Отёк сустава
- Утренняя скованность дольше 30 минут
- Боль, которая растёт от тренировки к тренировке, а не уменьшается

Ни один из этих пунктов не проходит «сам, если потерпеть». Терпение - хороший инструмент на дистанции и плохой в этом списке.

Чек-лист первой недели

Распечатайте или сохраните

Семь пунктов, к которым сводится всё остальное.

- ☐ Я определил свой сценарий перерыва: отпуск / болезнь / травма / выгорание
- ☐ Я знаю свой прежний недельный объём и выбрал посильный старт с учётом причины перерыва.
- ☐ Все тренировки первой недели - в 1-2 зоне, разговорный темп
- ☐ Я возвращаю посильную частоту, а не пытаюсь сразу набрать прежнюю длительность.
- ☐ Я не смотрю на темп. Мой ориентир - пульс и ощущения
- ☐ Я замерил утренний пульс и записал его как точку отсчёта
- ☐ В начале возвращения я не проверяю форму стартами и контрольными.

Этот чек-лист применяется, когда нагрузка уже допустима. Он не заменяет медицинский допуск после болезни или травмы.

Утренний пульс · точка отсчёта

Прежний недельный объём

Объём на первую неделю

Что дальше

Всё, что выше, - это рамка. Её нужно соотнести со своей ситуацией.

Но когда я пишу человеку персональный план возвращения, я разбираюсь в вещах, которых в гайде быть не может.

- Из-за чего именно был перерыв и сколько он длился
- Каким был объём и структура до него
- Что происходит с пульсом сейчас, на конкретных тренировках
- Как проходит восстановление между тренировками
- Есть ли старт впереди, какой и когда
- Что уже было в истории травм

Только после этого понятно, возвращать человека за две недели или за два месяца.

Если хочется не угадывать

Напишите мне. Разберём, где вы сейчас, и соберём возврат под ваш старт.

Сайт · innatri.com

Instagram · [@inna.tri](https://www.instagram.com/inna.tri)

INNA TRI

Инна Рыжих · Тренер по бегу и триатлону

20 лет в спорте, 10 лет тренерской практики

На чём основан гайд

Cardiorespiratory and metabolic consequences of detraining in endurance athletes. *Frontiers in Physiology*, 2024.

Mujika I., Padilla S. Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part I & II. *Sports Medicine*, 2000.

Effects of Short- and Long-Term Detraining on Maximal Oxygen Uptake in Athletes: Systematic Review and Meta-Analysis. *BioMed Research International*, 2022.

Skeletal muscle memory: implications for sports, aging and nutrition. *Frontiers in Nutrition*, 2025.

2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Cardiovascular Sequelae of COVID-19 in Adults: Myocarditis and Other Myocardial Involvement, Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection, and Return to Play.

Цифры в гайде округлены и приведены как ориентир. Индивидуальный разброс всегда больше, чем средние значения в исследованиях: на одного и того же человека влияют возраст, тренировочный стаж, качество сна и то, чем именно был заполнен перерыв.

Источники уточнений

МОК, 2022. Acute respiratory illness in athletes, part 1: acute respiratory infections.

Buist et al., 2008. Исследование программы с правилом 10% у начинающих бегунов.

George et al., 2024. Возвращение к бегу после стрессовой травмы большеберцовой кости. Не универсальный протокол для всех травм.

Meeusen et al., 2013. Консенсус ECSS/ACSM по перетренированности.

NHS. Chest pain: признаки для экстренной помощи.

INNA TRI

RUNNING ESSENTIAL STUDIO ·
INNATRI.COM